

Г.У.Тилеген¹, Ю.В.Войновский², М.Б.Муканова¹
РГКП на ПХВ КазНИИ онкологии и радиологии¹
ГКП на ПХВ Алматинский региональный онкологический диспансер²

Центральный венозный и внутрикостный доступ

9-10 февраля 2015 года в РГКП на ПХВ Казахском научно-исследовательском институте онкологии и радиологии прошел мастер-класс по продукции компании «TELEFLEXMedical» (США). Мастер-класс проводился представительством фирмы в Республике Казахстан «MEDICALMARCETINGGROUPL.L.C.».

Тематика мастер-класса:

1.Центральные венозные катетеры периферического введения (PICC-Peripherally Inserted Central Venous Catheter).

2.Устройство для внутрикостного доступа EZ-IO.

3.Устройство для трепанбиопсии OnControl.

На мастер-классе присутствовали врачи анестезиологи-реаниматологи и онкологи медицинских учреждений города Алматы и Алматинской области, а так же сотрудники кафедры анестезиологии и реаниматологии Казахского медицинского университета непрерывного образования, всего 36 человек.

Презентации по тематике мастер-класса проводил генеральный директор «TELEFLEXMedical» по маркетингу Димитрис Карампинис (DimitrisF.Karampinis). По окончании каждой темы лектору пришлось отвечать на многочисленные вопросы аудитории, т.к. данная тематика вызвала неподдельный интерес. Наибольшее количество вопросов было задано по PICC катетерам. Это связано с тем, что присутствовали на мероприятии в основном сотрудники учреждений онкологического профиля, а PICC катетеры преимущественно применяются в онкологии.

Краткое содержание презентаций

1.Центральные венозные катетеры периферического введения.

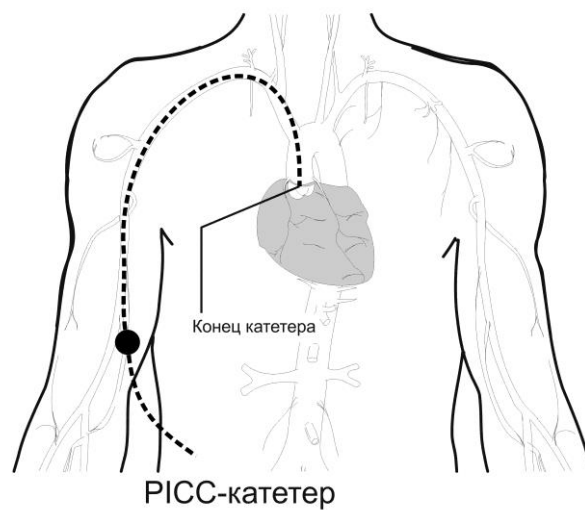
PICC-катетеры были впервые предложены в 1975 году, как альтернатива центральным венозным катетерам, вводимым непосредственно в подключичную, яремную или бедренную вену. Данный вид катетеров даёт меньше инфекционных осложнений, чем обычные центральные венозные катетеры, не встречаются случаи пневмо- и гидроторакса, повреждения артерий и гематомы. Срок службы катетера от 1 месяца до 1 года.

Для установки данных катетеров используются вены плеча (v.cerhalica или v.basilica). Вена визуализируется под УЗИ- контролем. Дистальный конец катетера находится в верхней поллой вене у входа в правое предсердие.

Показания: необходимость длительного внутривенного введения инфузионных растворов с осмолярностью более 600 мосм/л и с pH < 5 и > 9, то есть длительные курсы химиотерапии, антибиотикотерапии и парентеральное питание.

2. Устройство для внутрикостного доступа EZ-IO.

Протоколы экстренной медицинской помощи в США и Европе предусматривают установку внутрикостного доступа, как способа выбора, если не удаётся установить внутривенный доступ с 3 или 4 попытки или за более, чем 90 секунд (The new 2005 resuscitation guidelines of the European Resuscitation Council: comments and supplements // Anaesthetist. — 2006 Sep. — 55(9). — 95866, 96872, 9749. <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16915404>, 2005



American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. — Part 7.2. Management of Cardiac Arrest).

Система внутрикостного доступа применяется у взрослых и детей при оказании экстренной помощи в случаях, когда обычный сосудистый доступ затруднён или необходимо немедленно начать введение инфузионных сред.

EZ-IO является единственным в мире устройством внутрикостного доступа с электрическим батарейным приводом, используется в настоящее время в 50 странах (более 2 миллионов применений). FDA в 2004 году одобрило использование EZ-IO на проксимальном эпифизе большеберцовой кости и на головке плечевой кости. Система состоит из дрели на литиевых батареях, игл-наконечников разных размеров и переходников EZ-коннект, обеспечивающих соединение с инфузионной системой.

При использовании мешка под давлением или инфузионного насоса скорость инфузии посредством EZ-IO такая же, как и при внутривенном введении (большеберцовый доступ- до 64 мл/мин, плечевой- до 208 мл/мин).

3. Устройство для трепанбиопсии OnControl.

Инновационное устройство трепанбиопсии OnControl предназначено для установления гематологического диагноза, диагностики метастазов в костную ткань, а так же диагностики прочей патологии костной ткани методом аспирации как у взрослых, так и детей. Состоит из электрического приспособления (типа дрели), обеспечивающего внутрикостный доступ, системы доставки и собственно биопсийных игл. Зоны применения:

ребень подвздошной кости, тело позвонков, длинные трубчатые кости. Преимущества устройства: скорость и простота применения, получение более качественных биоптатов.

Устройство для внутрикостного доступа EZ-IO и устройство для трепанбиопсии OnControl в настоящее время находятся на регистрации в Республике Казахстан.

После окончания презентаций и ответов лектора на вопросы присутствующий на мероприятии директор

«MEDICALMARCETINGGROUPL.L.C.». Майкл Дорфман (M.O.Dorfman) сказал: « В зале не так много людей. Некоторые мастер - классы и тренинги собирают полные залы. Эффект от этого чаще всего бывает небольшой. Намного лучше обучить всего несколько человек, зато они наверняка будут делать то, о чём здесь говорилось ».

На второй день мастер-класса проведено практическое занятие по установке PICC катетеров и был установлен первый катетер данного типа в Республике Казахстан.